

УДК: 616.155.392.036.11

Г.М. Курманова

Центральный военный госпиталь КНБ РК, г.Алматы

Тромбофилические маски острого лейкоза

Аннотация. Острые лейкозы (ОЛ) представляют собой гетерогенную группу опухолевых заболеваний системы крови - гемобластозов, которые характеризуются первичным поражением костного мозга морфологически незрелыми кроветворными (бластными) клетками с вытеснением ими нормальных элементов и инфильтрацией ими различных тканей и органов. Клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса.

Острый лейкоз - злокачественное заболевание органов кроветворения, характеризующееся клеточной гиперплазией в кроветворных органах. Созревание прекращается на самых ранних, бластных этапах созревания. Патологические процессы, возникающие в системе кроветворения имеют свое отражение во всех тканях организма. Острые лейкозы возникают внезапно, симулируя острые заболевания (грипп, ангину и т.д.). Теория возникновения заболевания полиэтиологична. Для острого лейкоза характерны - острые расстройства кровообращения и язвенно-некротические осложнения, геморрагический синдром. По литературным данным (В.Г.Лычев, Р.А.Комиссарова и др., 1980) у 1/3 больных острым лейкозом на разных этапах заболевания развивается ДВС -синдром, при котором возможны переходы от тромботических осложнений к геморрагическим и наоборот. В литературе (Неймарк Е.З., 1975) описаны отдельные случаи тромбозов мозговых вен и синусов при заболеваниях крови. Ведущим симптомом острого лейкоза в полости рта является кровоточивость десен и язвенно-некротические поражения слизистой оболочки. По данным Ю.Н.Поповой, только у 8 больных из 87 не было изменений в полости рта. Описанное ниже клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза.

Больная Б., 1955 г.р. поступила в стоматологическое отделение ЦВГ КНБ РК 05.04.2011г с диагнозом: тромбоз глубоких вен лица справа, тромбоз кавернозного синуса. Заболела остро 03.04. -появились боли в горле при глотании, увеличились подчелюстные лимфоузлы с обеих сторон, повысилась температура до 38,0 градусов. 04.04.11 появился отек в подглазничной, скуловой, щечной областях справа, боли в костях и общая слабость. Утром 05.04.11 больная обратилась за медицинской помощью. При поступлении - общее состояние тяжелое, температура 39,0, выраженная общая слабость, резко выраженная асимметрия лица за счет отека мягких тканей подглазничной, скуловой и щечной областей справа. Кожные покровы бледные, чистые. Правая глазная щель закрыта за счет отека века. Кожа

век гиперемирована. В около-ушножевательной области справа - врожденная, поверхностная капиллярная гемангиома = 6,5 на 7 см, без признаков воспаления. При пальпации скуловой, подглазничной и щечной областей справа определяется незначительная болезненность. Увеличены и болезненны подчелюстные и шейные лимфоузлы с обеих сторон. Рот открывается свободно, слизистая полости рта и зева - чистая, бледная, влажная, блестящая. Десны плотные, зубы интактные, переходная складка в области 765432 зубов отечная, сглажена, пальпация слегка болезненная. Перкуссия зубов 7654321 - безболезненная. Границы легких в пределах нормы, дыхание везикулярное. Сердечные тоны приглушены, ритмичные, АД 120/75 мм.рт.ст., пульс - 84 уд. в мин. Печень и селезенка не увеличены. За время осмотра у больной увеличился отек на лице справа, появился отек и гиперемия века левого глаза. Больная осмотрена окулистом - выраженная инъекция сосудов склеры, картина начальных застойных сосков зрительных нервов. Лор - органы без особенностей, на ППН пневматизация пазух не нарушена. Больная осмотрена нейрохирургом -рекомендовано ЯМРТ. При исследовании системы гемостаза-гипокоагуляция, время свертываемости крови, на момент осмотра - 21 мин. Больная госпитализирована в реанимационное отделение. Общий анализ крови от 05.04.11 - эритроциты - $3,4 \cdot 10^{12}$ в 1 мкл, Нb 85 гл, Цв показатель - 0,79, гематокрит - 28%, тромбоциты - $85 \cdot 10^9$ л, лейкоциты - $1,0 \cdot 10^9$ л, п.-4, с-25, лимф.-40, мон.-1, СОЭ - 74 мм.ч, анизоцитоз ++, лейкоцитоз++. В нейтрофилах - выраженная токсическая зернистость. Больная консультирована гематологом. В миелограмме - пунктат малоклеточный, представлен в основном лимфоцитами (24,2%) и бластами (47,2%). Красный и гранулоцитарный ростки сужены. На основании клинико-гематологического статуса выставлен диагноз - острый лейкоз. Больная переведена в гематологическое отделение ТГКБ, где больная дообследована. На основании цитохимического исследования, иммунофенотипирования выставлен диагноз острый промиелоцитарный лейкоз.

Описанное клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза у этой больной характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса.

Список литературы

1. Баркаган З.С. Гемморагические заболевания и синдромы.-М., 180.
2. Боровский Е.В., Кташкилейсон А.А., Виноградова Т.Ф., Абрамова Е.И. Заболевания слизистой оболочки полости рта, губ // М.-1980
3. Неймарк Е.З. ...Тромбозы внутричерепных синусов и вен //М.-1975.

*Summary**G.M.Kurmanova**Central Military Hospital NSC RK**State trombositogrammy patients with Schonlein-Henochpurpura*

Acute leukemias (AL) are heterogeneous group of tumorous diseases of the blood - hemoblastoses, which are characterized by a primary bone marrow by morphologically primitive hematopoietic (blast) cells with displacement of normal elements and infiltration of various tissues and organs. Clinical supervision is of interest because of deep venous thrombosis of face was the primary sign of acute leukemia. The flow of acute leukemia was characterized by a significant inhibition of all germs of blood, severe complications, including deep venous thrombosis of face on the right and cavernous sinus thrombosis.

Key words: acute leukemia, Schonlein-Henochpurpura, platelets, complications

*Тұжырым**Г.К. Курманова**Шенлейн-Генох пурпурасы бар науқастардың тромбоцитограмманың күйі**ҚР ҰҚК орталық әскери госпиталі*

Жедел лейкоздар қан жүйесінің ісік ауруларының ішіндегі жетілмеген қан түзуші (бласты) жасушалардың сүйек майын біріншілік зақымдануымен және олардың қалыпты элементтерді ығыстыруымен, әр түрлі тіндер мен мүшелерде шоғырлануымен сипатталатын гетерогенді тобы – гемобластоздарды құрайды. Клиникалық бақылаулар беттің терең көк тамырларының тромбозы жедел лейкоздың алғашқы белгісі болуымен қызықтырады. Жедел лейкоздың ағымы барлық қан түзуші өсінділеріне қысым көрсетумен, ауыр асқынулардың дамуымен, соның ішінде оң жақ беттің терең көк тамырларының тромбозымен және кавернозды синустың тромбозымен сипатталды.

Түйінді сөздер жедел лейкоз, Шенлейн-Генох пурпурасы, тромбоциттер, асқыну